

Te same powikłania *ale waga „w normie”*

Atypowa AN: wszystkie objawy AN plus znacząca utrata wagi, ale BMI w normie lub wyższe. Te same powikłania medyczne. Najczęściej pomijana postać.

CZAS: 15-20 min psychoedukacji **REALIZACJA:** każda ocena pacjenta z restrykcją

ŹRÓDŁO: Whitelaw i in. (2014, *Pediatrics*); Garber i in. (2022, *Pediatrics*, ~25-40% hospitalizacji); Sawyer i in. (2016, atypowa AN); APA (2013, DSM-5, OSFED); WHO (2022, ICD-11, 6B80.Y)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **definicja atypowej AN** i dlaczego jest „niewidzialna”. W sekcji 02 — **kluczowe badania** Whitelaw i Garber dokumentujące *te same* powikłania medyczne. Sekcja 03 — **praktyczna ocena**: kalkulacja procentu utraty masy + obserwacja klinicznych powikłań. Sekcja 04 — przeciwdziałanie mitowi „nie jestem wystarczająco chudy/-a”.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Atypowa AN (ang. *atypical anorexia nervosa*, kategoria OSFED) — spełnione wszystkie kryteria AN *poza* niską masą. Pacjent stracił znaczącą wagę, ma lęk przed przyrostem i zaburzony obraz ciała, ale BMI mieści się w „normie”. **Mit „mniej groźna” jest błędny:** powikłania medyczne (bradykardia, hipokaliemia, brak miesiączki) występują z podobną częstością, a opóźnienie diagnozy jest dłuższe (Sawyer i in., 2016, *Pediatrics*). Klinicznie traktujemy identycznie z klasyczną AN.

01 Atypowa AN — definicja i dlaczego niewidzialna

CO SPEŁNIA KRYTERIA

Wszystkie kryteria AN: znacząca utrata wagi (więcej niż 10-15% masy wyjściowej), lęk przed przytyciem, zaburzony obraz ciała, restrykcja lub kompensacje.

Czego brakuje: *tylko* kryterium istotnie niskiej masy ciała. BMI jest w normie lub wyższe.

DLACZEGO NIEWIDZIALNA

Klasyczny obraz AN — bardzo niska waga — używany jest jako kryterium poszukiwania diagnozy. Pacjent z normalną wagą, który *schudł dużo*, często jest **chwalony** za „*schudnięcie*”, zamiast oceniony. Konsekwencja: miesiące lub lata bez leczenia.

02 🕒 Kluczowe badania — te same powikłania, mniejsza widoczność

Whitelaw i in. (2014, *Pediatrics*): pacjenci z atypową AN mają tę samą częstość i powagę powikłań medycznych co klasyczna AN — bradykardia (zwolnienie serca), hipotensja (niskie ciśnienie), brak miesiączki, hipokaliemia (niski potas), hipofosfatemia (niski fosfor). Powikłania nie zależą od bezwzględnej wagi — zależą od skali i tempa utraty.

Garber i in. (2022, *Pediatrics*): atypowa AN stanowi około 25–40% hospitalizacji z powodu powikłań AN u młodzieży. To *nie* jest rzadka anomalia — to istotny segment populacji klinicznej.

Predyktor powikłań: *utrata wagi większa niż 25% w mniej niż roku* jest bardziej predykcyjna dla powikłań medycznych niż aktualne BMI. Próg alarmowy: więcej niż 15% w 6 miesięcy lub więcej niż 25% w roku — *niezależnie* od masy wyjściowej.

03 ✎ Praktyczna ocena — pytania o historię wagi

HISTORIA WAGI

— *największa waga w życiu, aktualna, kiedy zaczął się spadek, jak szybko*

PROCENT UTRACONEJ MASY

— $(waga\ maksymalna - aktualna) / waga\ maksymalna \times 100\%$.
Próg alarmowy: > 15% w 6 mies. lub > 25% w 1 rok

SYGNAŁY SOMATYCZNE

— bradykardia (HR < 60), hipotensja, ortostazyzm, brak miesiączki (u kobiet, > 3 cykle), zaburzenia snu, koncentracji

KOMENTARZE OTOCZENIA, NA KTÓRE JA/BLISKA OSOBA REAGUJE

— „świetnie wyglądasz”, „pochwała schudnięcia”; ważne dla pracy z kontekstem kulturowym i wstydem

Klucz: mit „*nie jestem wystarczająco chudy/-a, by mieć anoreksję*” to najczęściej słyszane zdanie u pacjentów z atypową AN — i *najczęściej* opóźniające leczenie. **Diagnoza nie zależy od wagi** — zależy od mechanizmów psychicznych (lęk wagi, zaburzony obraz ciała, restrykcja) i powikłań medycznych. Whitelaw i in. (2014) pokazali, że pacjenci z atypową AN mają te same powikłania: bradykardię, hipotensję, brak miesiączki, zaburzenia elektrolitowe. Garber i in. (2022): atypowa AN to 25–40% hospitalizacji — nie rzadkość. Klinicznie: zawsze pytaj o historię wagi, nie tylko aktualną. Pacjent, który schudł dużo, nawet jeśli BMI jest „w normie”, wymaga oceny zaburzeń odżywiania. Komentarz otoczenia („*świetnie wyglądasz, schudłeś*”) jest częścią problemu — utrwała wzorec i opóźnia leczenie. Edukacja rodziny i otoczenia jest tu kluczowa.

△ Pacjent z atypową AN często wstydzi się prosić o pomoc („*nie zasługuję na leczenie, są ludzie chudsi, gorsi*”). To zinternalizowany mit wagi jako jedyne kryterium. Walidacja: „*twoje objawy zasługują na uwagę niezależnie od liczby na wadze. Powikłania medyczne nie pytają, ile ważysz — pytają, ile straciłeś/-aś i jak szybko*”. Linia wsparcia: 116 123 (dorośli), 116 111 (młodzież). Ośrodki specjalistyczne ED: lokalna informacja u psychiatry.